جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ماجده اسماعيل عبد القادر عيسي

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** دار السلام **العنوان :** 7 ح-احمد مصطفي -ش مطر

رقم البطاقة : 25510120100907 **رقم التليفون :** 01554863952 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 12-10-1955 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ماجده اسماعيل عبد القادر عيسى
National ID: 25510120100907

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: ماجده اسماعيل عبد القادر **MR. :** 7687	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is undergoing neoadjuvant chemotherapy (NACT) for triple-positive breast cancer (TPBC). The planned surgical approach is modified radical mastectomy (MRM) followed by post-operative radiotherapy (PORT). Adjunctive targeted therapy includes anti-HER2 agents and the aromatase inhibitor femara; however, femara has been discontinued due to a dental problem. Zometa has also been stopped for the same reason. No supportive care approval has been obtained at this time.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

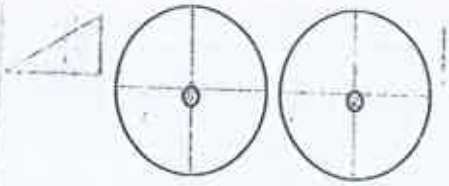
يعتمد ,

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

23/8/2021

Name	ماجدة إسماعيل
Age	65
MRN	
ID	
Co morbidity	- Diabetic hypertensive +ve Family history



Clinical Data cT3 N2 M0

Bx:	SM:
IHC: Tripple positive ER: 91 8 PR: 6 18 HerY: 13 Kiv: 251	Mets Workup: CTS Bone scan free
T N M c 3 2 0 cl	
COMMENT: Pt - post NACT - pt received AC 4 Then 1 Taxotere Then 9 WK Taxol + herceptin x 4 By examination No masses felt last 6/9 Received one (4) herceptin only.	Done scan

MDT OUTCOME & PLAN

MDT Form missing

13-9-2021 for CESM the Pt post NAT → complete radiological response (residual micro calcification & no enhancement.) for MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

امانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
إداره المعمل
قسم الباثولوجى

Pathology Report

Name: ماجده اسماعيل عبد القادر	**Age: 65years**
Clinical data:Left breast lesion	
Specimen type: true cut biopsy	
Date (received): 27/10/2020	**Date (reported): 27/10/2020**
Lab. Number: 1735	**Hospital Number:4669 / 2020**

Gross Description:

Five greyish white tissue cores , The longest is 1.3cm long. totally submitted.

Microscopic Examination & Diagnosis:

Left breast lesion , Core biopsy;
Invasive Duct carcinoma, GII.

Prof. Dr. Gamal A. Aty

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Health Insurance Organization
Nasr City Cancer Center
(NCCC

الهيئة العامة للتأمين الصحي
مركز أورام مدينة نصر

تاريخ الخدمة : 2020/12/15

Immunohistochemistry report

Lab-No.:20/984

-Procedure:

-Sections immunostained for ER, PR, Ki67 and Her2neu using supersensitive monoclonal antibodies with Roche envision (Dextran substrate polymer) flex detection system. Pretreatment for heat induced epitope retrieval (HIER) was performed using flex target retrieval solution. Blocking of endogenous peroxidase was performed using Roche peroxidase blocking reagent DAB was used as a chromogene.

Results:

ER: Marked positivity, score (8/8).

PR: Marked positivity, score (8/8).

Her2: strong positivity, score =3+

Ki67: High ki67 (20-25%)

N.B: the slides are delivered to the patient.

Prof.Dr. Ibrahim Hassan

Date: 15-Dec-2020 Time: 09:35 am

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER
NUCLEAR MEDICINE UNIT

وزارة الصحة
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى معهد ناصر
Nasser Institute Hospital
مركز الأورام
وحدة الطب النووي

Patient Name: Majeedah Esmaeel Date: 2/1/2022

^{99m}Tc- ^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- Degenerative changes are noticed over dorso-lumbar vertebrae.
- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

The surveyed skeleton is free of any active osseous lesions.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

DR. Sherin Mahdy, MD

١٣٥١ كورنيش النيل - أعلى سان - شبرا - القاهرة
Tel.: 22039184 - 22039356 Fax: 22039 236

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Patient Name: Magda Ismail Abd Al Kader Eisa	Date : 26/07/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 13027

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Compared t o previous study dated 27.10.2021 the current study shows:

1. ***Chest:***

- Status post left MRM showing operative bed distortion, skin thickening and two drains.
- The previously noted left axillary operative bed soft tissue lesion is not visualized.
- Rather stationary course regarding the previously noted few bilateral scattered tiny pulmonary nodules, the largest is noted at anterior segment of right upper lung lobe measuring 6 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Mild cardiomegaly. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilobar hypodense thyroid nodules with enlarged left lobe and retrosternal extension.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name: Magda Ismail Abd Al Kader Eisa	Date : 26/07/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 13027

- Calcified anterior uterine wall fibroids are noted.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows stationary right iliac sclerotic lesion.

OPINION:

Follow up study showing:

- ***Status post left MRM showing resolution of the previously noted operative bed axillary nodule***
- ***Bilateral scattered pulmonary nodules likely inflammatory for follow up.***
- ***No definite hepatic metastatic deposits.***

Signature Prof. Mohamed Gomaa
30/07/2022 02:51 م
Dr. M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]